

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Cystostomy (Supra-Pubic)

معلومات الإقرار – نسخة المريض فغر (فتحة) المثانة البولية (فوق العانة)

1. What do I need to know about this procedure?

A supra-pubic cystotomy is a surgical drainage of the bladder by putting a urine drainage tube (catheter) into the lower abdomen. This may be done by putting a needle through the abdominal wall into the bladder or by making a small cut into the abdominal wall. The urine is then drained into a bag that is attached to the catheter.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.

1. ما الذي ينبغي على معرفته عن هذا الإجراء؟

فغر (فتحة) المثانة البولية فوق العانة ، هو إجراء جراحي يتم فيه إنشاء فتحة في المثانة البولية فوق منطقة العانة بغرض إفراغ المثانة من البول عن طريق وضع أنبوب تصريف (قسطرة) في أسفل البطن. قد يتم ذلك بوضع وتمير إبرة عبر الجدار البطني إلى داخل المثانة البولية ، أو بعمل شق جراحي صغير في الجدار البطني . يتم بعد ذلك تصريف البول إلى كيس موصول بالقسطرة.

2. التخدير الذي ألتقاه

سوف يتطلب هذا الإجراء تخدير .
اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات ، قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار داياباير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر ، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Rarely damage to the bowel during the passage of the needle or catheter. This may require further surgery.
- Urine may leak from around the tube.
- The needle or catheter may block or fall out of position. This may need to be re- inserted.

Notes to talk to my doctor about:

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- من النادر حدوث ضرر للأمعاء أثناء تمرير الإبرة أو القسطرة . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- تسرب البول من حول الأنبوب.
- قد يحدث انسداد في الإبرة أو القسطرة أو قد تسقط من مكانها. قد يتطلب ذلك إعادة إدخالها.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
